
Examen blanc de résidanat

Épreuve 1

17 Novembre 2022

I- Partie A : QCM

Veillez inscrire les réponses aux QCM dans la grille réservée aux QCM

Un nouveau-né âgé de 7 jours est ramené par ses parents aux urgences pédiatriques pour ictère cutanéomuqueux constaté depuis J3 de vie. A l'interrogatoire, les urines sont foncées et les selles décolorées.

1- Quel est votre premier diagnostic ?

A- Lithiase biliaire

B- Syndrome d'Alagille

C- Atrésie des voies biliaires

D- Déficit en alpha 1 antitrypsine

E- Mucoviscidose

2- L'examen d'imagerie, de première intention, que vous demandez sera:

A- Abdomen sans préparation

B- Echographie abdominale

C- Echographie cardiaque

D- Cholangiographie transhépatique

E- Radiographie de thorax

3- Le bilan sanguin montre ces anomalies :

A- Hyperbilirubinémie à prédominance libre

B- Hyperbilirubinémie à prédominance conjuguée

C- des Gamma glutamyl transpeptidases élevées

D- des Gamma glutamyl transpeptidases basses

E- Un taux bas des phosphatases alcalines

4- Le traitement de cette pathologie repose sur:

- A- Acide ursodésoxycholique
- B- Vitaminothérapie ADEK
- C- Antipyrétiques
- D- Transfusion sanguine
- E- Hépatoportoentérostomie

5- Le premier examen à demander devant une dysphagie de type fonctionnel est :

- A- Un transit œsophagien
- B- Une FOGD
- C- Un scanner thoraco-abdominal
- D- Une manométrie standard
- E- Une manométrie haute résolution

6- Dans l'achalasie primitive de type 1 :

- A- L'apéristaltisme œsophagien est constant.
- B- Les régurgitations apparaissent à un stade précoce de la maladie.
- C- Il existe un défaut de relaxation du SIO lors des déglutitions
- D- Il existe une prédominance masculine.
- E- Il existe un risque de dégénérescence au-delà de 10 à 15 ans d'évolution

7- Chez un patient souffrant de reflux gastro-œsophagien, l'apparition d'une dysphagie peut faire évoquer :

- A- Une sténose peptique
- B- Une œsophagite peptique
- C- Un adénocarcinome de l'œsophage
- D- Un carcinome épidermoïde de l'œsophage.
- E- Une achalasie.

8- Devant un patient présentant un ictère cholestatique avec cytolysé à 15 N vous évoquez :

- A - Une cirrhose biliaire primitive.
- B - Un accident de migration lithiasique.
- C - Une hépatite virale.
- D - Une tumeur de la tête du pancréas
- E - Une stéatose hépatique.

9- Un ictère cholestatique associé à une hépatomégalie siège de multiples nodules à l'échographie fait évoquer :

- A - Métastases hépatiques.
- B - Abscès du foie.
- C - Foie cardiaque.
- D - Stéatose hépatique.
- E - Angiomes.

- 10- Chez un patient ictérique, une origine hémolytique de l'ictère doit être évoquée devant l'association à :
- A - Une hépatomégalie.
 - B - Une splénomégalie.
 - C - Une pâleur cutanéomuqueuse.
 - D - Des adénopathies périphériques.
 - E - Une fièvre.
- 11- Un ictère cholestatique avec dilatation isolée des voies biliaires intrahépatiques à l'échographie vous évoque le(s) diagnostic(s) suivants :
- A- Un ampulome Vaterien.
 - B- Un cancer de la tête du pancréas.
 - C- Un cancer du hile du foie.
 - D- Une cholangite biliaire primitive.
 - F- Une hépatite virale chronique.
- 12- Un ictère cholestatique associé à un épisode de méléna peut être secondaire à :
- A- Un cholangiocarcinome du bas cholédoque.
 - B- Un ampulome Vaterien.
 - C- Une lithiasse de la voie biliaire principale compliquée.
 - D- Un kyste hydatique du foie compliqué
 - G- Un cancer du corps du pancréas.
- 13- Le diagnostic d'infection à *Helicobacter pylori* (HP) peut être fait par :
- A- Le test respiratoire à l'urée (breath test).
 - B- La sérologie.
 - C- Les hémocultures.
 - D- La recherche de la toxine de la bactérie dans les selles.
 - E- La coproculture.
- 14- Concernant l'ulcère gastrique associé à l'infection par HP :
- A- Le contrôle endoscopique n'est pas utile si le patient devient asymptomatique sous IPP.
 - B- Le traitement par IPP est nécessaire pendant au moins 6 semaines.
 - C- Le contrôle de l'éradication de HP est nécessaire.
 - D- Le traitement d'éradication de HP se base en première intention sur la trithérapie : IPP + Amoxicilline + Clarithromycine.
 - E- Peut se compliquer d'un ictère hémolytique.

- 15- Chez un patient présentant une diarrhée chronique, le diagnostic d'un syndrome de l'intestin irritable (troubles fonctionnels intestinaux) est évoqué devant :
- A - L'apparition ancienne des symptômes.
 - B - L'aspect liquide non glairo-sanglant de la diarrhée.
 - C - L'évolution intermittente des symptômes.
 - D - L'alternance avec des épisodes de constipation.
 - E - L'aggravation des symptômes dans les périodes de stress.
- 16- Chez un patient présentant une diarrhée chronique, le diagnostic d'une maladie de Crohn est évoqué devant :
- A- Une atteinte inflammatoire pancolique à la coloscopie
 - B - L'aspect segmentaire des lésions endoscopiques à la coloscopie.
 - C - Le caractère graisseux de la diarrhée
 - D - La présence d'une fistule anale
 - E - L'association à une sacro-iléite bilatérale.
- 17- Dans le cycle parasitaire du kyste hydatique du foie :
- A- L'homme est hôte définitif accidentel.
 - B- Le chien est contaminé par l'herbe souillée par les œufs du parasite.
 - C- Le mouton est un hôte intermédiaire.
 - D- Le parasite vit dans l'intestin du chien.
 - E- L'homme s'infeste par l'ingestion d'abats parasités.
- 18- L'association d'une fièvre et d'un ictère à une douleur de l'HCD chez un jeune patient porteur d'un KH du foie évoque en premier lieu :
- A- Une suppuration de la cavité kystique
 - B- Une rupture du kyste en péritoine libre
 - C- Une ouverture du kyste dans le thorax
 - D- Une ouverture du kyste dans les voies biliaires
 - E- Une compression extrinsèque du pédicule hépatique
- 19- La rupture du kyste hydatique dans le péritoine est suspectée devant :
- A- Une urticaire
 - B- Un état de choc
 - C- Une angiocholite aiguë
 - D- Une vomique hydatique
 - E- Une défense abdominale généralisée
- 20- Parmi les facteurs de risque des cancers colorectaux on retient :
- A. les polypes inflammatoires.
 - B. le régime pauvre en fibres alimentaires.
 - C. La corticothérapie à long court.
 - D. La maladie de Crohn à localisation colorectale.
 - E. L'obésité morbide.

- 21- Ils sont considérés à risque élevé de cancer colique :
- A. Les parents du 1^{er} degré d'un patient atteint d'un cancer du rectum à l'âge de 50 ans.
 - B. Les patients porteurs d'une Polypose Adénomateuse familiale.
 - C. Les sujets âgés de plus que 50 ans.
 - D. Les patients porteurs d'une Rectocolite ulcéro-hémorragique évoluant depuis 20 ans.
 - E. Les patients porteurs d'un syndrome de lynch.
- 22- Concernant les complications des cancers colorectaux :
- A. L'abcès est plus fréquent pour les cancers du côlon droit.
 - B. La fistule recto-vaginale est un mode de révélation exceptionnel du cancer du rectum.
 - C. L'occlusion est plus fréquente pour les cancers de la charnière recto sigmoïdienne.
 - D. L'occlusion est la complication la plus fréquente indépendamment de la localisation tumorale.
 - E. La perforation colique est toujours à distance de la tumeur, de siège caecal.
- 23- Chez un patient qui présente un cancer du rectum, héli circonférentiel et fixe au toucher rectal, le bilan d'extension doit comporter :
- A. Un scanner thoraco- abdominal.
 - B. Un uro-Scanner.
 - C. Une IRM pelvienne.
 - D. Une coloscopie totale.
 - E. Une échographie endo-rectale.
- 24- La présence d'un adénocarcinome de l'angle colique gauche stade T2 N1 M0 doit imposer dans le cadre d'un traitement curatif :
- A. Une colectomie segmentaire basse et une chimiothérapie adjuvante.
 - B. Une radio chimiothérapie.
 - C. Une colectomie segmentaire haute et une chimiothérapie adjuvante.
 - D. Une héli colectomie gauche et une chimiothérapie adjuvante.
 - E. Une héli colectomie gauche seule.
- 25- Concernant les hémorragies digestives basses d'origines grêliques, on retient :
- A. L'Angiodysplasie est l'étiologie la plus fréquente chez l'adulte.
 - B. Le diverticule de Meckel est une étiologie possible chez l'enfant.
 - C. L'adénocarcinome est une cause de cette hémorragie qu'il faudra chercher si le patient présente un syndrome de Koenig et un amaigrissement associés.
 - D. Le lymphome constitue la première cause.
 - E. La maladie de Crohn représente 60% des étiologies.

26- Parmi les données suivantes quel(s) est (sont) en faveur d'une hémorragie digestive abondante :

- A. Les chiffres de PAS à 80mmhg.
- B. l'âge > 70 ans.
- C. Un chiffre d'hématocrite à 39 %.
- D. La survenue chez un patient suivi pour une d'insuffisance respiratoire.
- E. la transfusion de cinq culots globulaires pendant 24 premières heures pour stabiliser l'état hémodynamique.

27- Le traitement des lésions intra-épithéliales de haut grade :

- A- Est strictement chirurgical.
- B- Se fait par conisation avec des limites saines chez la femme jeune.
- C- La chimiothérapie est indiquée en adjuvant si les limites sont atteintes.
- D- La vaporisation au laser est une alternative à la chirurgie.
- E- Le suivi post-thérapeutique se base sur la cytologie et le test HPV.

28- Le dépistage du cancer du col utérin par frottis cervico-utérin exclut :

- A- Les femmes âgées de plus de 60 ans.
- B- Les vierges.
- C- Les femmes enceintes.
- D- Les femmes ayant eu une hystérectomie totale.
- E- Les femmes ayant reçu un vaccin anti HPV tétravalent à l'adolescence.

29- L'infection par le HPV :

- A- Est une maladie sexuellement transmise
- B- Est rare
- C- Transitoire
- D- Guérit spontanément
- E- Précède les lésions précancéreuses de quelques mois

30- Parmi les propositions suivantes concernant le cancer du col utérin, l'une est fausse :

- A- Le cancer du col in situ survient habituellement plus tôt que le cancer invasif
- B- Il est très lymphophile
- C- Il est hormono-dépendant.
- D- Il se manifeste rarement par des métastases à distance
- E- Il bénéficie actuellement d'une prévention primaire par un vaccin nonavalent

31- Les étiologies de l'hémorragie du post partum immédiat sont :

- A- Les anomalies des contractions utérines
- B- Rétention de produit de conception
- C- Les malformations utérines
- D- Les traumatismes du tractus génital
- E- Les anomalies de la coagulation (thrombine)

32- Devant une suspicion de GEU chez une jeune femme ayant des métrorragies, une échographie normale :

- A- Elimine le diagnostic de GEU
- B- Doit être associée au dosage de B HCG**
- C- Doit être recontrôlé dans les 48h si BHCG positifs**
- D- Doit faire pratiquer une coelioscopie
- E- Doit faire pratiquer une aspiration de la cavité utérine

33- Chez une femme porteuse d'un DIU qui présente des métrorragies, les 2 premiers diagnostics à évoquer sont :

- A- Une salpingite**
- B- Une fausse couche spontanée
- C- Une GEU**
- D- Une hyperplasie de l'endomètre
- E- Un fibrome sous séreux

34- Les métrorragies en rapport avec un placenta prævia sont caractérisées par :

- A- L'aspect rouge vif**
- B- La tendance à la récurrence**
- C- L'absence de souffrance fœtale**
- D- La douleur brutale associée
- E- Leur apparition typique au début du deuxième trimestre

35- Indiquez les 2 explorations préconisées de première intention chez une femme ménopausée depuis 5 ans qui présente des métrorragies évoluant depuis 3 mois :

- A- Une IRM pelvienne
- B- Une échographie endo-vaginale**
- C- Une hystéroscopie avec biopsies dirigées**
- D- Une TDM pelvienne
- E- Une hystérographie

36- Sur le plan histologique le cancer du sein est :

- A. Rapidement métastatique
- B. Souvent bilatéral
- C. Dominés par les adénocarcinomes
- D. Les sarcomes sont fréquents
- E. Lymphophile**

37- Le carcinome canalaire in situ

- A. Accessible au dépistage**
- B. Peut se manifester par un écoulement sanguinolent**
- C. Peut être multicentrique**
- D. Peut être bilatéral**
- E. N'évolue pas vers un carcinome infiltrant

38- Face à un cancer du sein T3, il faut systématiquement demander :

- A. Scintigraphie osseuse
- B. Échographie abdominopelvienne
- C. TDM cérébral
- D. Rx thorax
- E. Rx bassin

39- En cas d'endocardite d'Osler une ou plusieurs complications peuvent survenir ?

- A. Une insuffisance cardiaque.
- B. Des troubles de la conduction auriculo-ventriculaire.
- C. Un infarctus splénique.
- D. Des embolies cérébrales.
- E. Une néphropathie tubulaire

40- A propos de l'endocardite infectieuse subaigüe d'OSLER, quelle (s) est (sont) la ou les propositions exactes ?

- A. Elle contre-indique la chirurgie de remplacement valvulaire
- B. Le germe le plus habituellement en cause est un staphylocoque
- C. Elle survient habituellement sur un cœur pathologique
- D. Elle impose le recours aux anticoagulants en raison du risque embolique
- E. Elle peut provoquer l'apparition de végétations

41- A propos des endocardites infectieuses aiguës :

- A. Le germe le plus souvent en cause est un *Staphylococcus aureus*
- B. La porte d'entrée est le plus souvent évidente
- C. La fièvre est habituellement modérée mais continue autour de 38°C
- D. Elles apparaissent plus fréquemment chez l'immunodéprimé
- E. Elles entraînent des mutilations valvulaires importantes

42- L'endocardite subaigüe d'Osler :

- A. Associe le plus souvent une fièvre et un souffle diastolique d'insuffisance aortique
- B. Se greffe plus fréquemment sur une CIA que sur une bicuspidie aortique
- C. Peut se compliquer de glomérulopathie par dépôts glomérulaires de complexes immuns
- D. Se révèle par des faux panaris d'Osler uniquement lorsque le germe est un streptocoque
- E. A comme critère de guérison la disparition des végétations sur l'échocardiographie

43- La sémiologie de l'accès maniaque comporte tous les signes suivants, sauf un, lequel ?

- A- Une agitation
- B- Une logorrhée
- C- Une hypersomnie
- D- Un optimisme excessif
- E- Une fuite des idées

44- Les situations suivantes, sont compatibles avec le diagnostic d'un trouble bipolaire I :

- A- Un accès maniaque et un épisode dépressif majeur**
- B- Deux épisodes dépressifs majeurs et un accès hypomaniaque
- C- Un accès hypomaniaque isolé
- D- Deux épisodes dépressifs
- E- Deux accès maniaques et deux épisodes dépressifs majeurs**

45- Le trouble bipolaire peut se compliquer :

- A- d'un suicide**
- B- d'une tentative de suicide**
- C- d'une consommation de substances**
- D- d'un acte médico légal**
- E- D'un syndrome dissociatif

46- Les confusions mentales ou délirium:

- A. Evoluent toujours vers un état démentiel
- B. Sont le plus souvent d'origine toxique**
- C. Ont comme symptomatologie principale des troubles de l'humeur
- D. S'accompagnent dans les formes aiguës d'une hyperthermie**
- E. Peuvent mettre en jeu le pronostic vital**

47- Le syndrome confusionnel se caractérise par les affirmations :

- A. Des troubles de la mémoire sont constants**
- B. De L'onirisme constamment retrouvé
- C. L'étiologie la plus fréquente est psychiatrique
- D. La perplexité anxieuse est un des symptômes caractéristiques**
- E. Le contact verbal est impossible

48- Parmi les symptômes suivants, ceux qui caractérisent un syndrome confusionnel sont :

- A. Le délire paranoïde
- B. L'amnésie sélective
- C. Le troubles de la vigilance**
- D. La fabulation compensatrice**
- E. Les fausses reconnaissances**

49- Parmi les propositions suivantes, celle(s) qui peut (peuvent) entrainer un syndrome confusionnel est (sont) :

- A. La schizophrénie
- B. L'hypoglycémie**
- C. L'hypercuprémie**
- D. Le trouble panique
- E. L'intoxication au plomb

50- La sémiologie des confusions mentales ou delirium comporte :

- A. Des troubles de la mémoire
- B. Un délire de persécution
- C. Des hallucinations visuelles
- D. Une agitation anxieuse
- E. Un automatisme mental

51- Le Trouble Anxiété Généralisée peut comporter :

- A. Des douleurs articulaires
- B. Des rituels de vérifications
- C. Des attaques de panique répétitives
- D. Des bizarreries du comportement
- E. Des troubles de la concentration

52- Une attaque de panique se caractérise par :

- A. Des idées de culpabilité
- B. Un début et une fin aigues
- C. Des troubles cardio-respiratoires au premier plan
- D. Des idées obsédantes de contamination
- E. Une détresse psychologique marquée

53- Le trouble panique est :

- A. Un trouble anxieux
- B. Défini par l'existence d'attaques de panique inter critiques
- C. D'origine génétique
- D. Caractérisé par l'existence d'une anxiété anticipatoire
- E. Peu invalidant

54- Le trouble stress post traumatique :

- A. S'accompagne d'une désinhibition sexuelle
- B. Se caractérise par le syndrome de répétition
- C. Dure moins d'une semaine
- D. Survient immédiatement après un traumatisme majeur
- E. Comporte des attaques de panique récurrentes

55- Parmi les symptômes suivants, quels sont ceux qui font partie des signes physiques de l'anxiété ?

- A. Les palpitations.
- B. Les hallucinations visuelles
- C. La sensation d'oppression thoracique
- D. L'amnésie de fixation
- E. La sensation de boule œsophagienne

56- La ou les affections suivantes justifient une antibiothérapie chez un enfant de 6 ans :

- A- Une angine vésiculeuse
- B- Une herpangine
- C- Une otite moyenne aigue hyperalgique
- D- Une éthmoidite aigue non extériorisée
- E- Une otite congestive

57- L'angine à de Vincent :

- A- Survient chez l'enfant de moins de 3 ans.
- B- Survient volontiers par épidémies saisonnières.
- C- S'accompagne habituellement de fièvre et de douleur intenses
- D- Est causée par une association fusospirillaire
- E- Justifie une antibiothérapie systématique

58- Les alternatives thérapeutiques à considérer chez un enfant âgé de 6 ans qui présente une angine streptococcique sont :

- A- L'Amoxicilline à la dose de 50mg/kg/j en 2 prises pendant 6 jours
- B- La Cefpodoxime-proxetil à la dose de 8 mg/kg/j en 2 prises pendant 5 jours en cas d'allergie à la Pénicilline
- C- L'Azithromycine: 20 mg/kg/j pendant 3 jours en cas d'allergie aux B lactamines
- D- L'Amoxicilline-Acide Clavulanique à la dose de 80mk/kg/j pendant 6 jours
- E- La lévofloxacine 500mg/j pendant 5 jours

59- Parmi les signes de gravité d'une éthmoïdite aigue extériorisée, on retiendra :

- A- La mydriase
- B- L'œdème palpébral unilatéral douloureux
- C- L'ophtalmoplégie
- D- La thrombophlébite du sinus caverneux à la TDM
- E- La présence d'une exophtalmie

60- Le cancer du cavum :

- A- Le carcinome épidermoïde non kératinisant bien différencié est le type histologique le plus fréquent en Tunisie
- B- L'obstruction nasale est le motif de consultation le plus fréquent
- C- Peut donner une atteinte de l'oculomotricité
- D- Est fréquemment révélé par des métastases ganglionnaires
- E- Peut-être révélé par une dermatomyosite

61- Parmi les facteurs de risque retrouvés dans l'éthiopathogénie des cancers du cavum de type UCNT, on retient :

- A. L'alcool et le tabac
- B. L'infection par le HPV
- C. Le formaldéhyde
- D. L'origine d'Asie du Sud et de l'Afrique du Nord
- E. Les nitrosamines volatiles

62- Le cavum :

- A. Constitue la partie moyenne du pharynx
- B. Contient des formations lymphoïdes au niveau de ses parois latérales
- C. est délimité latéralement et en profondeur par le fascia pharyngo basilaire
- D. S'ouvre en avant par les choanes
- E. répond en haut et latéralement au sinus caverneux

63- Une biopsie ganglionnaire ou une adénectomie sont indiquées dans les situations suivantes :

- A. Une adénopathie suspecte de lymphome hodgkinien
- B. Une adénopathie sous digastrique associée à un processus tumoral du cavum
- C. Une Adénopathie métastatique sans primitif
- D. Une Adénopathie associée à une angine pseudo membraneuse
- E. Une tuberculose ganglionnaire résistante au traitement médical

64- Les résistances bronchiques (Raw) sont augmentées:

- A- sous l'effet des Leucotriènes
- B- en fin d'expiration forcée
- C- sous l'action du système nerveux sympathique
- D- sous l'effet de l'atropine
- E- sous l'effet de la Neurokinine A

65- Un déficit ventilatoire restrictif est défini par une diminution :

- A- de la pression partielle d'oxygène dans le sang artériel
- B- de la capacité pulmonaire totale
- C- de la capacité vitale
- D- du rapport de Tiffeneau
- E- de la compliance pulmonaire

66- Un déficit ventilatoire obstructif intra-thoracique proximal est défini par :

- A- Une baisse du volume expiratoire maximum seconde (VEMS)
- B- Une augmentation du volume résiduel (VR)
- C- Une baisse de la capacité vitale (CV)
- D- Une baisse du rapport VEMS/CV
- E- Une augmentation de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF)

67- En cas d'asthme bronchique :

- A- Le déficit ventilatoire obstructif (DVO) est fixe
- B- Le test de bronchodilatation peut être positif
- C- Il y a variabilité du DVO
- D- Les résistances bronchiques sont augmentées
- E- Le test de provocation bronchique est indispensable pour confirmer le diagnostic

Partie II : CCQCM

Cette partie comprend cas cliniques. Les réponses doivent être inscrites sur la grille réservée aux CCQCM

Cas clinique 1 :

Monsieur KL âgé de 75 ans se plaint depuis 6 mois d'une dysphagie localisée au niveau de la région cervicale, associée à une haleine fétide. Il se plaint par ailleurs de fausses routes à répétitions. Il vous dit que la palpation de la région cervicale fait régurgiter des aliments non digérés et que cette manœuvre soulage la dysphagie.

1- Le diagnostic le plus probable est :

- A- Un syndrome de Plummer- Vinson
- B- Une œsophagite peptique
- C- Un diverticule de Zenker
- D- Une achalasie
- E- Un cancer de l'œsophage

2- Chez ce malade :

- A- Un transit œsophagien doit être réalisé avant l'endoscopie.
- B- Une manométrie doit être réalisée avant l'endoscopie
- C- Un scanner cervical doit être réalisé avant l'endoscopie
- D- La FOGD est contre-indiquée.
- E- La FOGD doit être prudente.

Cas clinique 2 :

Patiente de 27 ans, se plaint depuis 2 semaines d'asthénie intense avec ictère.

A l'interrogatoire on note une anorexie, une somnolence, des vomissements post-prandiaux et des polyarthralgies. La patiente rapporte qu'elle est toxicomane et qu'elle n'a pas eu de vaccination contre l'hépatite virale B.

A l'examen physique on note un score de Glasgow à 15/15, un ictère cutanéomuqueux franc et une hépatomégalie de 14 cm, ferme et à bord inférieur moussé.

Vous évoquez le diagnostic d'hépatite virale aiguë.

3- Vous retenir comme signe(s) clinique(s) évoquant une hépatite grave chez cette patiente :

- A- L'asthénie.
- B- L'hépatomégalie.
- C- Les polyarthralgies.
- D- Les vomissements.
- E- La somnolence.

4- L'examen biologique qui permet d'évaluer la gravité de l'hépatite aiguë chez cette patiente est:

- A- Taux des transaminases sériques.
- B- Taux de bilirubinémie
- C- Taux des plaquettes.
- D- **Taux de prothrombine.**
- E- Taux d'hémoglobine.

5- Le diagnostic d'hépatite aiguë grave est porté chez cette femme. Quelle recherche doit être positive pour rapporter au virus B cette hépatite aiguë ?

- A- Recherche de l'antigène HBe
- B- Recherche d'anticorps anti-HBs
- C- Recherche de l'antigène HBc
- D- Recherche d'anticorps anti-HBe
- E- **Recherche d'anticorps anti-HBc de type IgM.**

6- L'évolution ultérieure de cette hépatite B peut être émaillée de(s) complication(s) suivante(s) :

- A- L'insuffisance rénale.
- B- Le lymphome hépatique.
- C- **La cirrhose du foie.**
- D- **Le carcinome hépato-cellulaire.**
- E- La pancréatite chronique.

7- Dans le cadre de l'enquête familiale, une sérologie B a été pratiquée chez le mari de la patiente et a montré les résultats suivants : AgHBs (-), Ac anti-HBs (+), Ac anti-HBc type IgM (-), Ac anti-HBc type IgG (+), AgHBe (-) , Ac anti-HBe (-).

Le profil sérologique B du mari vous évoque une des hypothèses suivantes :

- A- Hépatite B chronique non replicative.
- B- Hépatite B occulte.
- C- Hépatite B chronique répliquative.
- D- **Hépatite B ancienne immunisée.**
- E- Sujet vacciné contre le virus B.

Cas clinique 3 :

Une femme de 32 ans consulte pour un syndrome anémique et une diarrhée chronique liquidienne. L'examen clinique montre une pâleur cutanéomuqueuse. La biologie montre une anémie hypochrome microcytaire à 9g/dl avec ferritinémie basse. La fibroscopie œsogastroduodénale est normale. Les biopsies duodénales montrent une augmentation des lymphocytes intra épithéliaux >30%, une hyperplasie des cryptes et une atrophie villositaire subtotale.

Vous évoquez le diagnostic d'une maladie coeliaque.

8- Pour conforter votre diagnostic vous demandez :

- A- Dosage du facteur extrinsèque
- B- **Dosage des anticorps anti-transglutaminase**
- C- Electrophorèse des protéines
- D- Dosage des anticorps anti-cellules duodénales
- E- Dosage des anticorps anti-nucléaires.

9- Le traitement que vous proposez chez cette patiente est :

- A- Corticothérapie
- B- Traitement immunosuppresseur
- C- Traitement par immunoglobulines spécifiques
- D- Régime sans résidus
- E- **Régime sans gluten**

10- En cas de mauvaise observance du traitement, cette patiente sera exposée aux complications suivantes :

- A- **Lymphome intestinal**
- B- **Ostéopénie**
- C- Cancer gastrique
- D- Hypersplénisme
- E- **Cavitation ganglionnaire.**

Cas clinique 4 :

Patient âgé de 45 ans, originaire d'un milieu rural, consulte pour des douleurs de l'hypochondre droit, l'examen physique est sans particularités. L'échographie met en évidence une formation hépatique multiloculaire de 9 cm de diamètre au niveau du segment VIII. Vésicule et voies biliaires normales.

11- Parmi les diagnostics suivant quel est le plus probable :

- A- Abscess amibien
- B- Abscess à pyogène
- C- **Kyste hydatique du foie**
- D- Carcinome hépatocellulaire
- E- Angiome du foie

12- Pour confirmer le diagnostic, il faut demander la (les) exploration(s) suivante(s) :

- A- Une ponction biopsie
- B- **Une sérologie hydatique**
- C- **Un scanner abdominal**
- D- Une imagerie par résonance magnétique
- E- Une sérologie amibienne

13- En tenant compte du siège de la lésion, les 2 complications possibles sont :

- A- Ouverture dans le péritoine
- B- Ouverture dans le thorax
- C- Ouverture dans l'angle colique droit
- D- Ouverture dans les voies biliaires
- E- Un syndrome de Budd Chiari

14- Parmi les procédés chirurgicaux suivants quel est celui qui vous semble le plus approprié :

- A- Lobectomie droite
- B- Hépatectomie droite
- C- Drainage simple
- D- Résection du dôme saillant
- E- Périkysectomie totale

Cas clinique 5 :

Patient âgé de 57 ans qui se présente pour hémorragie digestive extériorisée sous forme de méléna ; l'EHD est stable. A la biologie : Hb = 7 g/dl et Ht = 22 %. La fibroscopie oeso gastro duodénale a montré la présence d'une perte de substance centimétrique de la face postérieure du bulbe duodénal stade II a de la classification de Forrest associé à un œdème péri-lésionnel.

15- Quelle est votre conduite à tenir :

- A. Administrer des IPP à la dose de 8mg/h.
- B. Prescrire des Anti inflammatoires non stéroïdiens de courte durée.
- C. Indiquer un traitement endoscopique.
- D. Perfuser par du sérum physiologique.
- E. Transfuser le patient.

16- l'évolution a été marquée par l'arrêt du saignement, il faut :

- A. Autoriser l'alimentation par voie orale.
- B. Indiquer une séance de traitement endoscopique.
- C. Renforcer l'hémostase spontanée par une embolisation.
- D. Indiquer une quadrithérapie.
- E. Prolonger la surveillance du patient.

17- A J2 d'hospitalisation, le patient a présenté des hématomèses. En sachant que l'EHD est devenue instable, il faudra proposer en urgence :

- A. Une hémostase chirurgicale.
- B. L'injection d'un produit sclérosant.
- C. Une artériographie et une embolisation.
- D. L'injection d'adrénaline pour assurer une vasoconstriction.
- E. La transfusion par du sang total.

Cas clinique 6:

Un patient âgé de 50 ans, hypertendu, consulte aux urgences pour une douleur thoracique transfixiante, permanente, d'installation brutale et irradiante vers le dos.

L'examen physique met en évidence une pression artérielle à 200/100 mmHg au bras droit et 120/70mmHg au bras gauche, l'auscultation cardio-pulmonaire ainsi que l'électrocardiogramme sont normaux.

18- A ce stade de l'examen, quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Une dissection aortique
- B. Une embolie pulmonaire
- C. Un pneumothorax
- D. Une pancréatite aigue
- E. Un syndrome coronarien aigu

19- Quel examen demandez-vous de première intention pour confirmer votre diagnostic ?

- A. Un angioscanner aortique
- B. Un angioscanner thoracique
- C. Une échographie cardiaque trans-thoracique
- D. Une échographie cardiaque trans-oesophagienne
- E. Une radiographie de thorax

Avant de réaliser cet examen, le patient a présenté brutalement une dyspnée aigue. L'auscultation pulmonaire révèle des râles crépitants diffus et l'auscultation cardiaque met en évidence un souffle cardiaque.

20- Quel est votre diagnostic ?

- A. Une insuffisance aortique aigue secondaire à la dissection aortique
- B. Une insuffisance mitrale aigue par rupture du pilier mitral
- C. Une insuffisance mitrale aigue par rupture du cordage
- D. Une communication inter-ventriculaire par perforation septale
- E. Une HTAP sévère secondaire à une embolie pulmonaire massive

Cas clinique 7:

Un toxicomane consulte pour fièvre depuis 4 jours. L'examen met en évidence un souffle tricuspide avec des abcès aux points de pique. Le diagnostic d'endocardite infectieuse aigue sur valve tricuspide est suspecté.

21- Quel germe évoquez-vous en premier ?

- A. Staphylocoque doré
- B. Staphylococcus épidermidis
- C. Streptococcus bovis
- D. Entérocoque
- E. Pneumocoque

22- Quelles sont les examens qui permettent de confirmer le diagnostic ?

- A. ETT +ETO
- B. Hémocultures
- C. NFS
- D. Radiographie de thorax
- E. ECG

23- Quel traitement prescrivez-vous avant la documentation du germe en cause ?

- A. Ampicilline + Oxacilline + Gentamicine
- B. Ampicilline + Gentamicine
- C. Oxacilline + Gentamicine
- D. Vancomicine + Rifamicine + Gentamicine
- E. Ceftriaxone + Gentamicine

Quelques jours après, le patient a présenté une douleur basithoracique droite avec une dyspnée aiguë.

24- Quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous en premier ?

- A. Péricardite aiguë
- B. Embolie pulmonaire
- C. Infarctus du myocarde
- D. Myocardite aiguë
- E. Abscess pulmonaire droit

25- Quel(s) examen(s) demandez-vous pour confirmer votre (vos) diagnostic(s) ?

- A. IRM cardiaque
- B. Scanner cardiaque
- C. Coronarographie
- D. Echographie cardiaque
- E. Angioscanner thoracique

Cas clinique 8:

Un patient âgé de 65 ans, diabétique, consulte pour découverte fortuite de chiffres tensionnels élevés. L'examen somatique est sans particularités en dehors d'un surpoids et d'une pression artérielle mesurée à 2 reprises à 165/95 mmHg.

26- Comment estimez-vous le risque cardiovasculaire chez ce patient ?

- A. Risque très faible
- B. Risque faible
- C. Risque modéré
- D. Risque moyen
- E. Risque haut

27- Parmi ces examens, lesquels doivent être demandés systématiquement chez ce patient ?

- A. Une numération et formule sanguine (NFS)
- B. Un bilan lipidique
- C. Une recherche de microalbuminurie à la bandelette urinaire
- D. Les transaminases
- E. Un bilan thyroïdien

28- Les mesures hygiéno-diététiques que vous devez conseiller au patient sont :

- A. Une restriction hydrique
- B. Un régime sans sel
- C. Une activité physique d'intensité modérée
- D. Un régime alimentaire riche en protéines animales
- E. Une réduction du poids

29- Le médecin a décidé de prescrire une association de 2 antihypertenseurs. Parmi ces associations, lesquelles peuvent être indiquées en première intention chez ce patient ?

- A. Un inhibiteur de l'enzyme de conversion + un diurétique thiazidique
- B. Un inhibiteur calcique + un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II
- C. Un bêtabloquant + un inhibiteur calcique
- D. Un inhibiteur de l'enzyme de conversion + un inhibiteur calcique
- E. Un antihypertenseur central + un inhibiteur calcique

Cas clinique 9:

Un patient âgé de 60 ans, tabagique, consulte pour une douleur thoracique prolongée depuis 6 heures. Le diagnostic de syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST est suspecté et l'ECG a été réalisé.

30- Dans quel délai faut-il pratiquer l'ECG ?

- A. 10 minutes
- B. 5 minutes
- C. 30 minutes
- D. 60 minutes
- E. 20 minutes

31- Le diagnostic de syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST dans le territoire antérieur a été retenu. L'ECG dans ce cas peut montrer :

- A. Une onde T pointue ample et symétrique en antérieur
- B. Une onde Q de nécrose en DII DIII AVF
- C. Un sous décalage de ST en V1V2V3
- D. Un sous décalage de ST en DII DIII AVF
- E. Un sus-décalage de ST diffus et concave en haut

Juste après la réalisation de l'ECG, le patient a présenté une perte de conscience. L'examen trouve une pression artérielle imprenable et une tachycardie à 200 bpm.

32- Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Une tamponnade
- B. Une rupture de la paroi libre du VG
- C. Une insuffisance mitrale aiguë
- D. Une tachycardie ventriculaire**
- E. Une extension au ventricule droit

33- Quelle est votre conduite en urgence ?

- A. Drainage péricardique en urgence
- B. Remplacement valvulaire mitral en urgence
- C. Choc électrique externe en urgence**
- D. Cordarone 300 mg par voie intra-veineuse
- E. Un remplissage

Cas clinique 10:

Un homme de 35 ans est hospitalisé dans un tableau de troubles de la conscience, d'une pression artérielle basse à 80/50 mmHg, d'une froideur et marbrures des extrémités, d'un pouls rapide et filant, d'une hépatomégalie avec turgescence franche des veines jugulaires. Un plâtre lui a été posé 2 semaines auparavant pour fracture de jambe et l'interrogatoire de l'entourage ne révèle pas d'antécédents médicaux.

34- Quel diagnostic évoquez-vous en premier ?

- A. Une embolie pulmonaire à risque élevé**
- B. Un IDM inférieur étendu au VD
- C. Une tamponnade
- D. Un pneumothorax bilatéral suffocant
- E. Une dissection de l'aorte

35- Quel examen demandez-vous en premier pour guider votre attitude thérapeutique ?

- A. Une échographie cardiaque trans-thoracique**
- B. Une échographie cardiaque trans-oesophagienne
- C. Un angioscanner aortique
- D. Une coronarographie
- E. Une IRM thoracique

36- Une fois votre diagnostic est confirmé, votre attitude thérapeutique en urgence comporte :

- A. Un remplissage prudent**
- B. Une thrombolyse**
- C. La prescription d'HBPM
- D. Une angioplastie primaire
- E. Un drainage péricardique

Cas clinique 11 :

Madame T, âgée de 30 ans, divorcée, sans emploi, sans antécédents pathologiques vous est adressée pour tristesse de l'humeur.

La patiente, au visage crispé, se dit épuisée, sans espoir et pense que sa vie est un véritable échec. Elle se plaint d'avoir perdu tout sentiment envers son entourage. Elle ne prend plus goût à rien et a peur pour son avenir.

Lors de l'entretien, vous remarquez des gestes lents, une voix monotone ainsi qu'une pauvreté de la mimique et un trouble de la concentration.

L'examen clinique somatique et les examens complémentaires prescrits sont normaux.

37- Madame T présente :

- A. Une dépersonnalisation
- B. Des obsessions
- C. Des idées délirantes de culpabilité
- D. **Un ralentissement psychomoteur**
- E. Une fuite des idées

38- Parmi les diagnostics suivants, lequel, retenez-vous ?

- A. **Dépression**
- B. Trouble panique
- C. Conversion hystérique
- D. Trouble anxieux généralisé
- E. Confusion mentale

39- Quel élément clinique fondamental avez-vous oublié de rechercher lors de votre entretien ?

- A. Ruminations anxieuses
- B. Déshinhibition
- C. **Idées suicidaires**
- D. Négativisme
- E. Anesthésie affective.

Cas clinique 12 :

Vous examinez dans le cadre des urgences un jeune âgé de 19 ans, emmené par ses parents pour tentative de suicide par strangulation. Les parents vous rapportent un changement de comportement depuis un an, associant un repli sur soi et un fléchissement scolaire. Le patient passait beaucoup de temps devant le miroir et paraît anxieux. L'épisode actuel remonte à deux mois, fait d'une aggravation de la symptomatologie avec apparition de comportements bizarres à type de fugue non motivé, le patient parle seul et refuse de manger les plats préparés à la maison.

A l'entretien, vous trouvez un patient réticent, il nie avoir fait une tentative de suicide et explique son geste par le fait qu'il doit accomplir sa mission et rejoindre sa vraie famille dans le paradis, qu'il a été kidnappé par la famille avec qui il vit actuellement et que les parents qui l'accompagnent veulent lui faire du mal et l'empoisonner. Le patient semble très angoissé.

40- le tableau psychiatrique de ce patient comporte :

- A. Une anhédonie
- B. Un syndrome dépressif
- C. Une dépersonnalisation
- D. Des signes négatifs
- E. Un syndrome de référence

41- le délire rapporté par le patient présente les caractéristiques suivantes :

- A. Délire de type paranoïde
- B. Vécu avec adhésion partielle
- C. Délire systématisé
- D. Forte participation affective
- E. Induit un comportement dangereux

42- le ou les diagnostic(s) que vous évoquez devant ce tableau est (ou sont) :

- A. Prise de substances psychoactives
- B. Un trouble bipolaire, épisode le plus récent dépressif avec caractéristiques psychotiques
- C. Un trouble délirant chronique
- D. Une schizophrénie
- E. un processus expansif intracrânien

43- l'examen clinique ainsi que les examens complémentaires sont sans anomalies. Votre prise en charge comportera :

- A. une prise en charge ambulatoire avec mise sous Fluoxétine à la dose de 20mg/j
- B. une hospitalisation au service de psychiatrie
- C. la mise sous anxiolytiques à forte dose et en monothérapie
- D. La mise sous un antipsychotique atypique type Risperidone à la dose de 4mg/jour
- E. La mise sous Amisulpride à la dose de 100mg/jour

44- le traitement que vous avez prescrit impose la surveillance des paramètres suivants :

- A. une numération formule sanguine hebdomadaire pendant 18 semaines
- B. la prise de température
- C. le calcul du BMI
- D. un examen neurologique à la recherche d'un syndrome extrapyramidal
- E. un électroencéphalogramme

Cas clinique 13 :

Monsieur B. 39 ans, a été retrouvé errant dans la rue. Ses papiers indiquent qu'il est de nationalité Russe. Il présente une instabilité motrice : il répète des gestes de préhension comme s'il voulait attraper ou chasser des objets autour de lui et apparaît anxieux.

Il ne répond pas aux questions, il semble angoissé et perdu, il répète la même phrase inlassablement « i told you it will happen! ».

L'examen clinique est normal, mis à part une fièvre à 38,3 degrés et des signes de déshydratation (soif, langue sèche, ébauche de pli cutané). L'examen neurologique est normal hormis un tremblement.

45- Parmi la liste de symptômes suivants, quel est celui ou quels sont ceux qu'on retrouve dans cette observation ?

- A. Bradypsychie
- B. Désorientation temporo-spatiale**
- C. Automatisme mental
- D. Dissociation
- E. Perplexité anxieuse**

46- A quel syndrome correspond ce tableau clinique ?

- A. Délire paranoïaque
- B. Schizophrénie paranoïde
- C. Confusion mentale**
- D. Accès maniaque
- E. Bouffée délirante

47- Quels examens devriez-vous demander immédiatement ?

- A. Bilan biologique standard, bilan hydroélectrolytique**
- B. Radiographie crane Face + Profil
- C. Electroencéphalogramme
- D. Bilan hépatique
- E. Tomodensitométrie Cérébrale**

Sa femme vous informe qu'il ne souffre d'aucune maladie organique et qu'il ne prend aucun traitement, mais qu'il essaye d'arrêter l'alcool depuis quelques jours

48- Quelle étiologie vous paraît la plus probable ?

- A. Sevrage aux opiacés
- B. Délirium Tremens**
- C. Epilepsie
- D. Ivresse pathologique
- E. Acido cétose diabétique

Cas clinique 14 :

Madame F, âgée de 24 ans, consulte au service de psychiatrie pour une symptomatologie anxieuse évoluant depuis plusieurs mois. Elle est institutrice dans une école privée, mariée depuis un an.

Elle rapporte qu'elle est hantée par la peur d'être contaminée par les microbes et les maladies. Elle reconnaît avoir des mesures d'hygiène excessives et passer plusieurs heures chaque jour à faire le ménage en utilisant divers produits antiseptiques quelle applique à plusieurs reprises sur toute la surface de sa maison.

49- Madame F présente :

- A. Des compulsions de vérifications
- B. Des obsessions phobiques
- C. Des obsessions idéiques
- D. Des compulsions de nettoyage
- E. Des obsessions impulsives

50- Les symptômes présentés par Madame F sont :

- A. Agréables
- B. Stéréotypés
- C. Egodystoniques
- D. Ressentis comme étant imposés de l'extérieur
- E. Sont à l'origine de l'anxiété

51- Les complications psychiatriques que peut présenter Madame F sont :

- A. Un épisode dépressif caractérisé
- B. Une schizophrénie
- C. Une manie délirante
- D. Une Agoraphobie
- E. Un trouble d'utilisation de substance

Cas clinique 15 :

Enfant âgé de 2 ans, est ramené aux urgences pour otalgies droites avec fièvre à 38°. A l'examen, conjonctivite purulente et à l'otoscopie un aspect d'otite moyenne aigue purulente droite.

52- Le germe potentiellement responsable de ce tableau clinique est :

- A. *Pseudomonas Aeruginosa*
- B. *Streptococcus pneumoniae*
- C. *Haemophilus influenzae*
- D. *Moraxella catarrhalis*
- E. *Staphylococcus aureus*

53- Sachant que l'enfant était sans antécédents particuliers, Quels traitements préconisez-vous de première intention dans ce cas :

- A. Amoxicilline à 80mg/kg/j pendant 8 jours
- B. Amoxicilline-Ac Clavulanique à 80mg/Kg/j pendants 8 jours
- C. Gouttes auriculaires à base d'antibiotiques
- D. Cefpodoxime à 8mg/kg/j
- E. Paracentèse

Après une semaine, les parents reconsultent pour réapparition de la fièvre, otorrhée purulente avec une tuméfaction rétro auriculaire droite inflammatoire de 4 cm.

54- Les examens complémentaires à demander sont :

- A. Une TDM cérébrale avec injection de produit de contraste
- B. Une Numération formule sanguine
- C. Une CRP
- D. Une échographie cervicale
- E. Un prélèvement bactériologique

55- Votre conduite thérapeutique doit comporter :

- A. Une hospitalisation
- B. Ceftriaxone + Fosfomycine en intraveineux
- C. Amoxicilline-Ac clavulanique avec réévaluation dans 48heures
- D. Un drainage chirurgical
- E. Une corticothérapie

Cas clinique 15 :

Patient âgé de 55 ans, tabagique consulte pour obstruction nasale droite avec rhinorrhée sanguinolente et plénitude auriculaire homolatérales évoluant depuis 6 mois. L'examen physique a objectivé une paralysie du VI droit, une adénopathie sous digastrique droite de 3 cm. Le diagnostic d'un cancer du cavum a été évoqué.

56- Les signes qui plaident en faveur de ce diagnostic chez ce patient sont :

- A- Le tabagisme
- B- La rhinorrhée sanguinolente
- C- L'otite séromuqueuse unilatérale
- D- L'adénopathie sous digastrique
- E- La paralysie du VI

57- L'atteinte du VI chez ce patient serait due à :

- A. une extension tumorale à l'espace rétrostylien
- B. Une extension au sinus caverneux
- C. Une atteinte de l'apex du rocher
- D. Une extension à l'apex orbitaire
- E. Une extension à la fosse infra temporale

Un bilan d'extension réalisé n'a pas montré des métastases à distance.

58- Votre conduite thérapeutique chez ce patient doit comporter :

- A- Une chimiothérapie néo adjuvante suivie de radio chimiothérapie concomitante
- B- Des soins dentaires avec confection de gouttière fluorée
- C- Une radio chimiothérapie concomitante
- D- Un curage ganglionnaire droit
- E- Une radiothérapie exclusive centrée sur le cavum et les aires ganglionnaires bilatérales

Cas clinique 16 :

Un homme de 45 ans, consulte pour des accès de perte de connaissance avec chute traumatique et des clonies des 4 membres.

L'interrogatoire a révélé que ce patient a eu des accès de sensation du jamais vu, jamais vécu » à plusieurs reprises de brève durée mais il n'a jamais consulté et cette fois ce phénomène a précédé la perte de connaissance.

59- Cette symptomatique clinique correspond à :

- A. Une crise focale avec rupture de contact
- B. Une crise tonico-clonique généralisée
- C. Une absence atypique
- D. Une crise focale avec bi latéralisation des crises tonico-cloniques
- E. Une crise non épileptique d'origine psychogène

60- Quelle topographie lésionnelle ?

- A. Frontale
- B. Temporale interne
- C. Pariétale
- D. Région péri insulaire
- E. Occipitale

61- Quelle(s) est (sont) la ou les étiologie(s) possible(s) ?

- A. Génétique
- B. Dysplasie corticale
- C. Séquelles d'un AVC sylvien profond
- D. Tumeur cérébrale
- E. Encéphalite auto-immune

Cas clinique 17 :

Patient âgé de 50 ans, droitier, diabétique sous antidiabétiques oraux, consulte aux urgences pour lourdeur membre inférieur droit associée à une hypoesthésie du même territoire il y a 3heures. Vous suspectez un AVC ischémique constitué.

62- L'artère touchée dans cet AVC est :

- A. La cérébrale antérieure gauche
- B. La sylvienne totale gauche
- C. La choroïdienne antérieure gauche
- D. La cérébrale postérieure gauche
- E. Le tronc basilaire

63- Ce patient peut présenter également :

- A. Une aphasie de Wernické
- B. Un réflexe de préhension de la main droite
- C. Une hémianopsie latérale homonyme droite
- D. Un syndrome dysexécutif
- E. Des persévérations

64- L'origine cardio-embolique d'un AVC est suspecté devant :

- A. Un sujet jeune
- B. Le sexe féminin
- C. Un AVC massif
- D. Un AVC bilatéral
- E. Des AIT à répétition

65- Les examens biologiques à demander en urgence sont :

- A. Une NFS avec plaquette
- B. Une glycémie
- C. Un INR
- D. Une vitesse de sédimentation
- E. Un bilan immunologique

66- La conduite thérapeutique en urgence chez ce patient comporte

- A. Anticoagulation
- B. Simple anti agrégation plaquettaire
- C. Double anti agrégation plaquettaire
- D. Thrombolyse intraveineuse
- E. Un traitement antioœdémateux

Cas clinique 18 :

Un jeune patient de 22 ans, asthmatique depuis l'âge de 12 ans, consulte les urgences pour une crise d'asthme évoluant depuis quelques heures.

A l'examen : sujet conscient, FR à 36 c/mn, FC : 125b/mn, T° 38,2°C, TA : 13/8, hyper sonorité à la percussion, râles sibilants à l'auscultation. Le débit expiratoire de pointe est à 100 L/mn (Normal : 600 L/mn), gaz du sang : PaO₂ : 60 mmHg, PCO₂ : 48 mmHg, pH : 7,32, saturation à l'air ambiant à 82%

67- les éléments en faveur de la sévérité de la crise chez ce patient sont :

- A- La fréquence respiratoire 36c/mn
- B- l'hyper sonorité à la percussion
- C- la température à 38,2°C
- D- le débit de pointe à 100 L/mn
- E- les données de la gazométrie sanguine

68- Le traitement de première intention dans ce cas comporte :

- A- les β_2 sympathomimétiques en nébulisation
- B- la nébulisation de corticoïdes
- C -L'oxygénothérapie
- D- la corticothérapie par voie générale
- E- la ventilation mécanique invasive

69- Le patient est revu 2 mois plus tard, il présente de rares épisodes d'oppression thoracique, la spirométrie à l'état de base montre : VEMS : 2,10 L (68% de la théorique), rapport VEMS/CVF : 65%. Le traitement de fond de l'asthme dans ce cas comporte :

A- les β_2 sympathomimétiques à la demande

B- les β_2 sympathomimétiques de longue action seules

C- la corticothérapie inhalée

D- la corticothérapie continue per os

E- les anticholinergiques en continu